

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT - NGÀ

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ
(Người bệnh có chỉ định tập phục hồi chức năng mắt)

Số: 02./QTKB/TĐYTVN
Ngày ban hành: 10./10/2025
Lần ban hành: 01

Trách nhiệm	Biên soạn thảo	Người phê duyệt
Chức vụ	Trần Thị Thảo Nguyên	Phó tổng giám đốc
Họ tên		BS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Ký tên		 

Lưu hành nội bộ





QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
(Người bệnh có chỉ định tập phục hồi chức năng mắt)

Mã số: ..02....
QTKB/TĐYTVN
Ngày ban hành:
10/10/2025
Lần ban hành: 01

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của tài liệu hướng dẫn quy trình này
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn
3. Mỗi cơ sở được phát 01 bản (có đóng dấu của người phê duyệt). Các cơ sở khi có nhu cầu thêm, đề nghị liên hệ với phòng KHTH – QLCL (Hà Nội) để có bản đóng dấu của người phê duyệt.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

☒	Ban lãnh đạo tập đoàn		
☒	Giám đốc các bệnh viện		

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

I. MỤC ĐÍCH

- Chuẩn hóa, thống nhất trình tự và nội dung các bước khám bệnh và chỉ định tập phục hồi chức năng mắt nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo cơ sở tích hợp phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS/EMR).

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh của Tập đoàn Y tế Việt – Nga.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;

- Quy chế bệnh viện 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997;

- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhân khoa;

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về quy trình giám định BHYT

- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 4750/ QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

BN : Bệnh nhân

NB : Người bệnh

BS : Bác sĩ

ĐD : Điều dưỡng

KTV : Kỹ thuật viên

TKX : Tật khúc xạ

CLS : Cận lâm sàng

KHTH : Kế hoạch tổng hợp

QLCL : Quản lý chất lượng

BV : Bệnh viện

QĐ : Quyết định

BYT : Bộ Y tế

CSKH : Chăm sóc khách hàng

PHCN : Phục hồi chức năng

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Các bước tiếp nhận và quản lý người bệnh khám mắt có chỉ định tập phục hồi chức năng tại bệnh viện

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 1: Đăng ký thông tin	Người bệnh /người nhà NB		Tại kiosk thông tin: - Tiếp nhận thông tin bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNeID/ CCCD hoặc có thể nhập trực tiếp thông tin người bệnh tại kiosk 1. Lựa chọn hình thức khám: - BHYT - Dịch vụ 2. Nhận STT <i>Đối với BN đã thực hiện đăng ký online qua app/ web bỏ qua bước này</i>	Cơ sở HCM có thêm hình thức khám theo yêu cầu (VIP)
Bước 2: Đăng ký khám bệnh	Lễ tân	Marketing /CSKH	- Tiếp nhận NB theo số TT - Khai thác sơ bộ lý do - Chọn gói khám - Chọn phòng khám / BS khám - In phiếu khám <i>(trong phiếu có hướng dẫn đến phòng khúc xạ/phòng chức năng + phòng khám và thứ tự cần thực hiện trước sau)</i> Đối với BN đăng ký online đã được Marketing tư vấn và tích gói khám -> lễ tân chỉ thực hiện in phiếu khám	CS HCM: Phát sinh STT theo đầu mã gói khám TQ – chuyên sâu – tái khám
Bước 3: Thu phí	Thu ngân		Thu phí - NB đóng phí khám bệnh theo bảng giá quy định tại Bệnh viện - Đẩy cổng check-in (đẩy tự động) – đối với NB đăng ký khám BHYT <i>NB có thể đóng phí bằng QR code động -> đưa bill giao dịch thành công cho thu ngân -> thu ngân xác nhận đã thanh toán -> BP. lễ tân đưa hồ sơ khám cho NB</i>	- CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí - CS HL, HP: Thu toàn bộ chi phí, kết thúc khám sẽ hoàn lại tiền cho bệnh nhân
Bước 4: Đo thị lực, khúc xạ và nhãn áp	KTV Khúc xạ/ điều dưỡng Phòng khúc xạ/ chức		NB cầm phiếu khám <i>(trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khúc xạ/phòng chức năng)</i> , thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng, thực hiện đo 1. Đo khúc xạ tự động 2. Đo thị lực:	* CS HN: -Thực hiện thêm chỉnh kính

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
	năng		- Không kính - Kính lỗ - Kính cũ (nếu có) 3. Đo nhãn áp hơi (nếu có) 4. Nhập toàn bộ kết quả lên phần mềm và in kết quả Hướng dẫn NB đến phòng có ghi trên phiếu khám	
Bước 5 Khám	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng khoa khám bệnh	NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng khám. Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ thực hiện khám chi tiết: - Hỏi bệnh - Khám sinh hiển vi - Soi đáy mắt - Chỉ định chỉnh kính (nếu có), điều dưỡng/KTV nhập số liệu cấp đơn kính - Tư vấn, GDSK, ghi nhận thông tin về tình trạng người bệnh trên phần mềm về tình trạng bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, chỉ định điều trị DD hỗ trợ BS giải đáp những thắc mắc liên quan đến KCB, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc mắt... cho NB trong phạm vi chuyên môn cho phép	CS HCM: Chỉnh kính (BS Nga tự chỉnh kính) – nếu có, BS Nga tự nhập KQ vào phần mềm trên form riêng của BS
Bước 6 Chỉ định CLS	Bác sĩ tại phòng khám		- NB được chỉ định thực hiện CLS: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng,... để trợ giúp chẩn đoán xác định: + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT-> chờ đến lượt -> thực hiện chỉ định CLS -> điều dưỡng/KTV đẩy hình ảnh lên Forum hoặc Pacs => NB quay trở lại phòng khám ban đầu (vào	Gói chỉ định CLS theo gói khám

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			<i>phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)</i>	
Bước 7 Đọc kết quả CLS	Bác sĩ/ phiên dịch tại phòng khám		- NB chờ đến lượt vào phòng khám theo sự điều phối của điều dưỡng - BS người Việt sẽ đọc và trả kết quả trên forum và Pacs, ký số trả kết quả - BS người Nga đọc và trả kết quả trên form và pacs, phiên dịch hỗ trợ dịch trên phiếu trả kết quả. BS và phiên dịch cùng ký trên phiếu trả kết quả CĐHA. Phiên dịch ký trước bằng chữ ký điện tử, BS ký sau và ký số.	
Bước 8 Hướng xử trí	Bác sĩ chuyên khoa		1. Các xử trí khác: - Chỉ định thêm CLS: Thực hiện tương tự như bước 6 - Chỉ định thủ thuật (tiểu phẫu): + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí KHÔNG THU PHÍ: chỉ định chỉnh kính/những cận lâm sàng thực hiện lặp lại theo yêu cầu của bác sĩ : in phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> thu phí (giảm trừ 100%) -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)-> thực hiện-> phòng khám ban đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng) - NB có chỉ định tập PHCN => chuyển phòng Marketing/CSKH	
Bước 9 Thực hiện thủ thuật (nếu có)	Điều dưỡng		1. NB Checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt 2. Mời người bệnh vào thực hiện theo STT 3. ĐD. Giải thích hướng dẫn người bệnh phối hợp - Thực hiện theo chỉ định - Trả kết quả trên PM - Hướng dẫn BN quay trở lại phòng khám để	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			phòng khám	
Bước 10 Tư vấn chi phí	BP. Tư vấn		NB/ thân nhân NB được tư vấn chi phí gói tập nhược thị (trong giờ, ngoài giờ...) Hướng dẫn NB/thân nhân NB quay về phòng khám ban đầu	
Bước 11 Chỉ định gói tập PHCN	Bác sĩ		NB quay về phòng khám ban đầu (<i>vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng</i>) Chỉ định gói tập phù hợp: Ghi rõ thời gian tập, số lượng máy tập, thời lượng mỗi ngày	
Bước 12 Thu phí	Thu ngân		Thu phí theo quy định của Bệnh viện	
Bước 13 Lập HSBA ngoại trú	Bác sĩ	ĐD. Khoa Khám bệnh	Lập HSBA ngoại trú	
Bước 14 Thực hiện	Bác sĩ	ĐD. Khoa Khám bệnh	<i>Từ ngày tập 1-10</i> - Mỗi ngày, NB đến Khoa Khám bệnh – Phòng nhược thị để thực hiện buổi tập theo chỉ định - Ghi nhận ngày tập trong HSBA ngoại trú - Hẹn NB quay lại vào ngày tập tiếp theo <i>ĐD phòng nhược thị hỗ trợ báo phòng BS tích chỉ định kể từ ngày tập thứ 2 – thứ 10 khi NB vào phòng tập</i> Kết thúc ngày tập thứ 9 hoặc thứ 10. Điều dưỡng tạm dừng điều trị trên phần mềm. Lưu ý: Nếu NB bắt buộc phải tạm dừng giữa gói tập (do những bệnh lý khác), ĐD tạm dừng điều trị trên phần mềm.	
Bước 15 Đăng ký tái khám sau đợt điều trị	Lễ tân	ĐD. Khoa Khám bệnh	Đăng ký tái khám sau đợt điều trị (<i>thực hiện như quy trình khám ngoại trú</i>): đăng ký -> thu phí (nếu có) -> khúc xạ, thị lực, nhãn áp (nếu có) -> phòng khám	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 16 Đánh giá sau gói tập	Bác sĩ	ĐD. Khoa Khám bệnh	NB cầm phiếu khám (trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ. BS đánh giá kết quả sau đợt điều trị, so sánh kết quả trước và sau tập Ghi nhận vào HSBA ngoại trú Dựa vào kết quả đạt được, BS đưa ra chỉ định: - Hoàn tất liệu trình nếu đạt kết quả - Tiếp tục đợt tập mới (ngày cụ thể) - Chuyển hướng điều trị Kê đơn thuốc + sản phẩm hỗ trợ sau điều trị (nếu có)	
Bước 17 Đóng phí đơn thuốc, Nhận thuốc	Thu ngân Kế toán BHYT	Khoa dược	1. Đối với NB không sử dụng BHYT - Được duyệt đơn thuốc, đến nhà thuốc bệnh viện xác nhận thuốc cần mua - Thanh toán chi phí các loại thuốc được bác sĩ kê trong đơn thuốc (L1) - Nhận thuốc tại nhà thuốc (Dược sĩ sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết, liều lượng, thời gian sử dụng, cách dùng, lưu ý khi dùng thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc, và các điều kiện đặc biệt cần tránh khi dùng thuốc.) 2. Đối với NB có sử dụng BHYT: - Được duyệt đơn thuốc, NB ký bảng kê chi phí tại khu vực kế toán BHYT (L3), KT BHYT giữ bảng kê chi phí (1 bảng) - Thu ngân thu chênh chi phí (nếu có) - Lĩnh thuốc BHYT tại nhà thuốc bệnh viện. Dược giữ 1 đơn thuốc (có đóng dấu đã thanh toán BHYT)	Cơ sở HL, HP: Hoàn lại tiền BHYT thanh toán cho người bệnh
Bước 18 Kết thúc khám	Bác sĩ	ĐD. Khoa Khám bệnh	Kết thúc đợt điều trị - Đóng HSBA ngoại trú	

Lưu ý:

1. Phát sinh mã QR động, NB có thể nộp phí ở bất kỳ đâu không cần đến quầy thu ngân
2. CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí
3. Khi xác nhận đã thu phí, tên NB mới thể hiện tại phòng có chỉ định để thực hiện trả kết quả

